

SPEECH COMPLETO — DEFENSA DEL TFM

"Cómo afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar"

Una revisión paraguas de meta-análisis en psicología clínica y de la salud (2016–2026)

Universidad Autónoma de Madrid · Máster en Psicología General Sanitaria

Duración estimada: 20–24 minutos

INSTRUCCIONES DE USO

[DIAPOSITIVA X] = cambia de slide en ese momento

(pausa) = 1-2 segundos de silencio, deja que el tribunal lea

Negrita = énfasis oral

Cursiva = dato técnico o nombre propio, pronuncia con precisión

[DIAPOSITIVA 1 — Portada]

Buenos días. Mi nombre es Denisa Antoneac, y presento mi Trabajo de Fin de Máster del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la tutela de la profesora Raquel Rodríguez Carvajal.

El trabajo se titula: **"Cómo afectan la autoestima y el autoconcepto al bienestar. Una revisión paraguas de meta-análisis en psicología clínica y de la salud, del año 2016 al 2026."**

La pregunta de fondo es aparentemente sencilla pero lleva más de un siglo sin resolverse del todo: ¿cómo se siente una persona sobre sí misma tiene algo que ver con cómo está, psicológica y físicamente+/- ¿Y en qué medida, en qué poblaciones, y a través de qué mecanismos+/-

[DIAPOSITIVA 2 — "Un siglo de estudio del self"]

pausa — deja que vean la línea temporal

Para entender qué mido en este trabajo, necesito situar el debate teórico que está detrás. Un debate que tiene más de ciento treinta años.

William James, 1890. Divide el self en dos: el *I* —el yo que actúa— y el *Me* —el yo como objeto de conocimiento. Primera idea de que el self no es una cosa única sino multidimensional.

Cooley, 1902. Propone el yo-espejo: nos vemos como *creemos* que nos ven los demás, no como nos ven realmente. Esto explica por qué el rechazo social o el estigma pueden distorsionar profundamente la imagen de uno mismo, incluso cuando los logros son objetivos.

G.H. Mead, 1934. El self no existe antes de la interacción social: se construye en ella. Internalizamos las expectativas del grupo y eso moldea quiénes creemos ser. Clave para entender por qué el estigma asociado a diagnósticos como obesidad o disforia de género erosiona el autoconcepto.

Rosenberg, 1965. Crea la **Escala de Autoestima de Rosenberg —RSES—**: diez afirmaciones sobre uno mismo, Likert de cuatro puntos, de libre acceso y validada en más de cincuenta culturas. Mide la **valoración global que una persona hace de sí misma** —cuánto se valora, si se siente digna de respeto—. Sigue siendo el instrumento más usado en el mundo para medir autoestima y el más frecuente en el corpus de mi trabajo.

Shavelson, 1976. Propone el modelo jerárquico y multidimensional del autoconcepto: en la cúspide, un autoconcepto general; debajo, el académico y el no académico; en la base, subdimensiones —físico, social, emocional. La consecuencia directa: alguien puede tener autoconcepto físico muy negativo y académico muy positivo. Si solo mides autoestima global, pierdes esa especificidad clínica.

Baumeister, 2003. Su meta-análisis concluye que los efectos *causales* de la autoestima son más modestos de lo que el campo había afirmado. No invalida el constructo, pero exige más rigor —y justifica revisiones como esta.

Y la nota al pie de esta diapositiva: las **falacias jingle y jangle**. Jingle es usar el mismo nombre para constructos distintos —llamar "autoestima" al autoconcepto físico. Jangle es lo contrario: nombres distintos para lo mismo. Ambas han contaminado décadas de literatura. Por eso este trabajo diferencia autoestima y autoconcepto en lugar de tratarlos como sinónimos.

[DIAPOSITIVA 3 — "Qué medimos exactamente"]

pausa

Una vez situado el debate teórico, la pregunta es: ¿con qué instrumentos operacionalizamos estos constructos+/-

La diapositiva muestra los tres bloques de variables del trabajo.

La **autoestima**: evaluativa y global. Responde a "¿cuánto me valoro+/-". Es la dimensión afectiva del self. Se mide con la **Rosenberg Self-Esteem Scale —RSES—**, el instrumento dominante en el corpus.

El **autoconcepto**: descriptivo y multidimensional. Responde a "¿cómo me veo en distintos ámbitos+/-". Incluye dominios académico, social, físico y corporal. Se mide con el **Self-Description Questionnaire** de Marsh y, cuando el foco es el cuerpo específicamente, con el *Physical Self-Description Questionnaire* —más frecuente en los bloques de obesidad e imagen corporal.

Y el **bienestar**: la variable resultado. Heterogéneo en el corpus —HRQoL, salud mental, satisfacción vital—. Esa heterogeneidad es uno de los desafíos metodológicos centrales y es la razón por la que organizo los resultados por bloques temáticos, no en un único número agregado.

[DIAPOSITIVA 4 — "El bienestar tiene cuatro caras"]

pausa

El bienestar no es un constructo unitario. Hay cuatro tradiciones que lo definen de forma diferente, y los meta-análisis del corpus las usan de forma no siempre equivalente.

El **bienestar subjetivo o hedónico**, de **Diener**: estar bien es tener más emociones positivas que negativas más satisfacción con la vida. Se mide con la SWLS o el PANAS. Es el más usado en psicología social, pero puede capturar bienestar superficial.

El **bienestar psicológico o eudaimónico**, de **Ryff**: bienestar no es sentirse bien, sino vivir bien y desarrollarse. Propone seis dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. Las más ligadas al self son la **autoaceptación** y el **propósito**. Este modelo aparece poco en el corpus clínico —un hallazgo en sí mismo: la clínica ha estado más centrada en eliminar el malestar que en promover el florecimiento.

La **calidad de vida relacionada con la salud**, o *HRQoL*: el impacto percibido de la enfermedad sobre el funcionamiento físico, psicológico y social. Mide con SF-36, EQ-5D o **WHOQOL-BREF**. Predomina en los bloques de salud somática y obesidad pediátrica.

Y la **salud mental general**, de **Keyes**: ausencia de enfermedad mental no equivale a salud mental. Son dos continuos independientes. Puedes tener diagnóstico y alta salud mental —*flourishing*—, o no tener diagnóstico pero estar en *languishing*. Esta distinción recuerda que el objetivo terapéutico no debe ser solo reducir síntomas, sino también construir recursos positivos —entre ellos, el autoconcepto.

[DIAPOSITIVA 5 — "Evidencia abundante... pero fragmentada"]

pausa

Con el marco teórico situado: ¿por qué una revisión más, si ya hay tanta investigación+/-

La evidencia es **abundante pero fragmentada**. Es una de las literaturas más voluminosas de toda la psicología. La síntesis más ambiciosa hasta la fecha es la de **Zell y Johansson**, de 2025, que agrega cuarenta meta-análisis y obtiene una correlación global de $r = .31$ —.42 para salud mental, .15 para salud física—. Pero tiene un problema fundamental: **mezcla población clínica y no clínica**, enmascarando efectos específicamente relevantes para la práctica.

El hueco que cubre este TFM tiene dos partes:

Primera: restrinjo la muestra a población clínica —al menos el 75% de cada meta-análisis debe tener diagnóstico o condición de salud. Esto permite responder a una pregunta clínicamente más específica y útil.

Segunda: integro tanto autoestima como autoconcepto —incluida la imagen corporal— como dos caras del mismo objeto, en lugar de colapsar todo en un único número.

Y aquí va el argumento clínico central: **las intervenciones se diseñan sobre constructos específicos**. Si quiero intervenir en la imagen corporal de un adolescente con obesidad, necesito saber si el autoconcepto físico predice su bienestar más que la autoestima global. Esa especificidad es lo que este trabajo intenta aportar.

[DIAPOSITIVA 6 — "Objetivos"]

pausa breve

El **objetivo general** es sintetizar, mediante una revisión paraguas siguiendo PRISMA 2020 y PRIOR, la evidencia meta-analítica sobre autoestima y/o autoconcepto y bienestar en psicología clínica y de la salud, entre 2016 y 2026.

Los **cuatro objetivos específicos** son:

Primero, identificar y describir los meta-análisis del periodo en poblaciones clínicas o de salud.

Segundo, sintetizar los tamaños del efecto —consistencias y discrepancias— por constructo, outcome y población.

Tercero, evaluar la calidad metodológica con AMSTAR-2 y el solapamiento entre revisiones con el CCA.

Y cuarto, identificar lagunas en la evidencia y proponer líneas de investigación futura.

[DIAPOSITIVA 7 — "Diseño y pregunta PECO"]

pausa

El diseño es una **revisión paraguas** —o *umbrella review*—. La unidad de análisis es el meta-análisis, no el estudio primario. Es el nivel más alto de síntesis en la jerarquía de evidencia. Seguí las guías **PRISMA 2020** y **PRIOR**, la extensión específica de PRISMA para revisiones de revisiones.

La pregunta se formuló en formato **PECO**:

- **P** Población: contexto clínico o de salud, con diagnóstico o enfermedad. Umbral del 75%.
- **E** Exposición: autoestima y/o autoconcepto, incluida imagen corporal, con instrumentos validados.
- **C** Comparador: flexible —implícito en los estudios correlacionales, o grupo control en los de intervención.
- **O** Outcome: bienestar subjetivo, psicológico, HRQoL o salud mental general.

El PECO —y no el PICOS— porque mi pregunta es observacional, sobre asociaciones, no sobre eficacia de intervenciones. Esa distinción define los criterios de inclusión y la estrategia de búsqueda.

[DIAPOSITIVA 8 — "Búsqueda y selección"]

pausa

La búsqueda se realizó en **cuatro bases de datos primarias**: PubMed/MEDLINE, APA PsycInfo, Scopus y Web of Science.

Se completó con **cinco fuentes de literatura gris**: PROSPERO, OSF, Google Scholar, TESEO y ProQuest Dissertations. La literatura gris es fundamental para reducir el **sesgo de publicación** —el fenómeno por el que los estudios con resultados positivos se publican más que los negativos.

La estrategia se estructuró en **tres bloques semánticos** conectados por AND: términos de exposición —autoestima, autoconcepto, RSES, SDQ—; términos de outcome —bienestar, HRQoL, salud mental—; y términos de diseño —meta-analysis, systematic review, umbrella review. Se usó vocabulario controlado MeSH en PubMed y el Thesaurus de APA en PsycInfo.

La gestión de referencias se hizo con **Rayyan**, con motivo de exclusión documentado para cada estudio rechazado.

Y aquí reconozco la **limitación principal** del proceso: el cribado y la extracción los realicé yo sola —revisora única. Lo ideal habría sido contar con una segunda revisora para calcular el acuerdo inter-jueces. Es una limitación real que el tribunal va a preguntar, y que ya asumo explícitamente en el trabajo.

[DIAPOSITIVA 9 — "El corpus: 13 meta-análisis"]

pausa

Tras el proceso de cribado, el corpus final quedó formado por **13 meta-análisis** que en conjunto comprenden aproximadamente **415 estudios primarios**, con un rango de k —número de estudios por meta-análisis— de entre 7 y 114, y una mediana de 19.

Lo primero que quiero destacar: el **Índice de Solapamiento Corregido —CCA— fue del 1,4%**. Esto indica solapamiento mínimo —el umbral de problema está en el 5%—, lo que valida la independencia del corpus. Los 13 meta-análisis están trabajando sobre bases de evidencia primaria mayoritariamente distintas.

La diversidad de poblaciones cubiertas es amplia: cinco meta-análisis sobre trastornos psiquiátricos —depresión, ansiedad, suicidalidad, TDAH—; tres sobre obesidad infantojuvenil; dos sobre salud reproductiva y población transgénero; uno sobre trastornos orofaciales; uno sobre víctimas de violencia; y uno sobre baja autoestima como condición clínica en sí misma.

[DIAPOSITIVA 10 — "La calidad del corpus pide cautela"]

pausa

Este es uno de los hallazgos más importantes del trabajo, y uno de los que más discusión va a generar con el tribunal.

Los resultados de AMSTAR-2 muestran un panorama preocupante: **solo 1 de los 13 meta-análisis —el 8%— alcanzó calidad Alta**. Ninguno obtuvo calidad Moderada. Seis —el 46%— obtuvieron calidad Baja. Y seis más —el otro 46%— fueron calificados como Críticamente bajos.

¿Qué significa esto+/- Los fallos más frecuentes son estructurales: ausencia de prerregistro, falta de evaluación del riesgo de sesgo de los estudios primarios, y ausencia de evaluación del sesgo de publicación. Esto no significa que los resultados sean falsos, sino que los tamaños del efecto pueden estar **sobreestimados** y que la replicabilidad es limitada.

Interpreto los resultados con cautela y diferenciando explícitamente entre el meta-análisis de calidad Alta —el del Bloque A, suicidalidad— cuyas conclusiones son sólidas, y el resto, que requieren mayor prudencia.

Y nótese: este mapa de calidad es en sí mismo un resultado. Señala que el campo necesita elevar sus estándares metodológicos.

[DIAPPOSITIVA 11 — "Síntesis: cinco bloques temáticos"]

pausa — señala cada bloque

Organicé los resultados en cinco bloques temáticos.

El **Bloque A**, marcado con una estrella en la diapositiva, es el más robusto: autoestima y salud mental clínica. El meta-análisis sobre suicidalidad incluye $k = 114$ estudios —el mayor del corpus— y es el único con calidad Alta. Las correlaciones entre autoestima y riesgo suicida van de $r = -.26$ a $-.44$: **a mayor autoestima, menor riesgo suicida**. Este efecto de tamaño moderado-grande justifica incluir la RSES como indicador en protocolos de prevención del suicidio. En este bloque también aparece la evidencia sobre el COMET y la terapia cognitiva de Fennell como intervenciones específicas sobre autoestima.

El **Bloque B** recoge salud somática —síndrome de ovario poliquístico y deformidad dentofacial—: autoestima y autoconcepto se asocian significativamente con la calidad de vida en estas condiciones, aunque la certeza de la evidencia es baja.

El **Bloque C**, obesidad pediátrica: la actividad física estructurada mejora simultáneamente autoestima, imagen corporal y estado de ánimo. Las diferencias de medias estandarizadas son $SMD \approx 0,34$ para autoestima global y $SMD \approx 0,47$ para imagen corporal —efectos pequeño-moderados y moderados respectivamente.

El **Bloque D**, imagen corporal en trastornos clínicos —exposición en TCA y atención de afirmación de género—. Los tamaños del efecto son los más grandes del corpus: g entre $-.46$ y $-.99$ en insatisfacción corporal. Con cautela por la calidad baja, pero clínicamente sugerentes.

Y el **Bloque E**, el más sofisticado metodológicamente: usando **MASEM** —meta-análisis de ecuaciones estructurales— con $k = 82$ estudios, el autoconcepto media la relación estigma internalizado y calidad de vida, con un **efecto indirecto de $\beta = -.189$** . El autoconcepto no es solo un correlato; es un **mecanismo activo** en la cadena que va del diagnóstico al deterioro del bienestar. Y eso tiene implicaciones directas para la intervención.

[DIAPPOSITIVA 12 — "Discusión: mensajes clave"]

pausa

Cuatro conclusiones vertebran la discusión.

Primera: la autoestima predice la salud mental clínica con efectos de tamaño moderado a fuerte, con su máximo en la suicidalidad.

Segunda: las intervenciones sobre la autoestima funcionan —con tamaños del efecto de g entre 0,20 y 0,50— y arrastran mejoras en la depresión comórbida.

Tercera: cuerpo, imagen y autoestima van juntos; la obesidad pediátrica es el ejemplo más maduro en el corpus.

Cuarta: la imagen corporal es modificable con intervenciones específicas en poblaciones clínicas —especialmente relevante para los protocolos en TCA y afirmación de género.

En conjunto, los resultados son **coherentes con Zell y Johansson 2025** — $r \approx .42$ para salud mental—, pero añaden el foco clínico, la distinción de constructos y el análisis de mecanismos mediadores que esa revisión no tenía.

[DIAPOSITIVA 13 — "Implicaciones clínicas"]

pausa

Tres implicaciones prácticas para el psicólogo sanitario.

Primera —la autoestima como diana de intervención directa: programas como el **COMET** —Competitive Memory Training— y la **terapia cognitiva de Fennell** tienen evidencia creciente en depresión, TCA y trastorno límite. Los datos de este trabajo justifican su uso en protocolos clínicos, no solo como complemento sino como componente central.

Segunda —integrar cuerpo, imagen y autoestima: el autoconcepto físico y la imagen corporal predicen bienestar de forma diferencial respecto a la autoestima global. La evaluación clínica debería incluir instrumentos multidimensionales —SDQ, PSDQ— y no limitarse a la RSES.

Tercera —cribado en prevención del suicidio: dada la correlación de hasta $-.44$ entre autoestima y suicidalidad, incluir la RSES en protocolos de triaje en urgencias psiquiátricas y atención primaria es una medida sencilla, barata y con alto valor predictivo.

[DIAPOSITIVA 14 — "Limitaciones y líneas futuras"]

pausa

Soy consciente de las limitaciones del trabajo y quiero ser transparente al respecto.

Del corpus: el 92% tiene calidad baja o críticamente baja; hay heterogeneidad de instrumentos y métricas difícil de homogeneizar; y algunos bloques están cubiertos por un único meta-análisis.

Del proceso: **revisora única en todo el proceso** —sin cálculo de acuerdo inter-jueces, lo que es la principal limitación metodológica—; restricción a inglés y español; ventana temporal 2016–2026; y sin gradación formal de la certeza de la evidencia con GRADE.

Las líneas futuras más urgentes son cinco: revisiones con **prerregistro en PROSPERO** y dos revisores; **estudios longitudinales** para establecer causalidad; uso sistemático de instrumentos de **autoconcepto multidimensional**; inclusión de **personas mayores y contextos no occidentales** —poblaciones subrepresentadas—; y **meta-análisis de red** para comparar la eficacia de distintas intervenciones sobre autoestima.

[DIAPOSITIVA 15 — "Conclusiones"]

pausa

Para cerrar, en cinco conclusiones:

Primera: baja autoestima y suicidalidad tienen la asociación más robusta del corpus — r hasta $-.44$, $k = 114$, calidad Alta—. Es el hallazgo más sólido y clínicamente más urgente.

Segunda: las intervenciones sobre la autoestima son eficaces con efectos moderados y mejoran la depresión comórbida.

Tercera: la actividad física mejora simultáneamente autoestima e imagen corporal en obesidad infantojuvenil —un resultado con implicaciones para los programas de salud escolar.

Cuarta: la imagen corporal es modificable con intervenciones específicas en poblaciones clínicas —TCA, disforia de género—, aunque la calidad de esa evidencia requiere más investigación.

Quinta: el autoconcepto media la relación entre estigma internalizado y calidad de vida — $\beta = -.189$ —, lo que lo convierte en un mecanismo psicológico modificable y en una diana terapéutica justificada.

En conjunto: **la autoestima y el autoconcepto no son desenlaces secundarios, sino objetivos de intervención valiosos en psicología clínica y de la salud**. Con la cautela que exige la calidad del corpus, los datos justifican integrar su evaluación y trabajo en los protocolos de tratamiento.

El sentido que nos damos a nosotros mismos no es un lujo psicológico: es un factor con impacto real y medible en la salud.

[DIAPOSITIVA 16 — Cierre]

Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para sus preguntas.

[Tiempo total estimado: 20-23 minutos]